

Pierre MARTIN	ID Patient : DEMO001	0 bilan(s) enregistre(s)
---------------	----------------------	--------------------------

BILAN ACTUEL			
Patient & Biologie renale		Tacrolimus & Ionogramme	
Age / Sexe:	52 ans - Homme	Phase post-greffe:	M3 - M12
Poids:	75.0 kg	C0 residuel:	6.5 ng/mL (Sous-therapeutique)
Creatinine:	110.0 umol/L	Cible C0:	8-12 ng/mL
DFG (Cockcroft-Gault):	73.6 mL/min	Dose actuelle:	4.0 mg/j
Stade KDIGO:	G2 - Légèrement v	Natremie Na+:	138.0 mmol/L - Normal
		Kaliemie K+:	4.2 mmol/L - Normal

Augmentation recommandee	
6.0 mg/j	3.0 mg matin + 3.0 mg soir (q12h, capsules Prograf)

INTERPRETATION CLINIQUE - JUSTIFICATION DE LA RECOMMANDATION
1. Contexte clinique
Patient de 52 ans (Homme), 75.0 kg, greffe cardiaque en phase M3 - M12. Fonction renale estimee par Cockcroft-Gault : DFG = 73.6 mL/min, stade KDIGO G2 (Légèrement dim.). C'est ce contexte renal qui conditionne le plafond de dose de tacrolimus.
2. Analyse pharmacocinetique (C0 residuel)
C0 = 6.5 ng/mL est dans la cible therapeutique (8-12 ng/mL). L'immunosuppression est optimale pour la phase M3 - M12. L'ajustement PK confirme 6.0 mg/j comme dose de maintien.
3. Augmentation de dose
La dose augmente de 4.0 mg/j a 6.0 mg/j conformement a l'ajustement PK, en restant sous le plafond nephroprotecteur de 7.5 mg/j (stade G2, facteur 1.0).
4. Conclusion et posologie
Dose recommandee : 6.0 mg/j soit 3.0 mg matin + 3.0 mg soir (q12h, capsules Prograf). Cette posologie represente le meilleur compromis entre l'efficacite immunosuppressive et la preservation de la fonction renale, conformement aux recommandations ISHLT 2016 (Kobashigawa et al., J Heart Lung Transplant) et aux donnees de la litterature.

RAISONNEMENT CLINIQUE ET METHODOLOGIE

1. Cockcroft-Gault (1976)

$$\text{DFG} = ((140-52) \times 75.0 \times 1.00) / (0.815 \times 110.0) = 73.6 \text{ mL/min} \Rightarrow \text{G2}$$

2. Ajustement PK proportionnel (Staatz & Tett, 2004)

$$4.0 \text{ mg/j} \times (10.0 / 6.5) = 6.15 \text{ mg/j} \Rightarrow \text{arrondi capsule } 0.5 \text{ mg} \Rightarrow 6.0 \text{ mg/j}$$

3. Plafond nephroprotecteur (Ojo 2003, Naesens 2009, Ekberg 2007)

$$75.0 \text{ kg} \times 0.1 \text{ mg/kg} \times \text{facteur DFG } 1.0 \text{ (stade G2)} = 7.5 \text{ mg/j}$$

4. Decision finale

$$\min(\text{PK } 6.0, \text{plafond } 7.5) = 6.0 \text{ mg/j} \Rightarrow 3.0 \text{ mg} \times 2 \text{ /j (q12h)}$$

RESUME DE CONSULTATION - MEDFLOW AI

Patient de 52 ans (sexe masculin) en post-transplantation cardiaque, phase M3-M12. La concentration residuelle de tacrolimus (C0 = 6,5 ng/mL) est en dessous de la cible therapeutique (8-12 ng/mL), exposant le patient a un risque de rejet sous-immunosuppression. La fonction renale est preservee (DFG 115 mL/min, stade G1) et l'ionogramme est normal. La dose de tacrolimus est augmentee de 4 mg/j a 4,5 mg/j (2,5 mg matin + 2,0 mg soir, q12h). Ce reajustement vise a ramener le C0 dans la fenetre therapeutique afin de prevenir un episode de rejet aigu.

Genere par MedFlow AI - outil d'aide a la decision

Outil d'aide a la decision clinique - Ne remplace pas la concertation d'equipe de transplantation. Adapter systematiquement au protocole institutionnel. MedFlow AI - Usage professionnel exclusif.

